

SPEECH PARA LA PRESENTACION DEL TFM

"Como afectan la autoestima y el autoconcepto al bienestar. Una revision paraguas de meta-analisis en psicologia clinica y de la salud (2016-2026)"

Duracion estimada: 20-25 minutos

****NOTA DE USO****: Los tiempos orientativos estan indicados entre corchetes. Habla con calma, con pausas naturales. No leas, interpreta. El tribunal valora la seguridad y el dominio del contenido, no la velocidad.

APERTURA -- [1 minuto]

Buenos días / Buenas tardes. Mi nombre es Denisa Antoneac, y hoy presento mi Trabajo Fin de Master del Master Universitario en Psicologia General Sanitaria de la Universidad Autonoma de Madrid.

El trabajo se titula: *"Como afectan la autoestima y el autoconcepto al bienestar. Una revision paraguas de meta-analisis en psicologia clinica y de la salud, del ano 2016 al 2026."*

Esta investigacion surge de una pregunta aparentemente sencilla pero que lleva mas de un siglo sin resolverse del todo: ¿como se siente una persona sobre si misma tiene algo que ver con como esta, tanto psicologica como fisicamente? Y si es asi, ¿en que medida, y en que poblaciones clinicas?

BLOQUE 1: MARCO TEORICO -- [4 minutos]

Para entender el trabajo, necesito situar primero que entendemos por los conceptos centrales: **autoestima, autoconcepto y bienestar**.

El self y su historia

El estudio del self tiene mas de un siglo. William James, en 1890, ya distinguia entre el Yo como agente y el Mi como objeto de conocimiento. Cooley y Mead aportaron la dimension social: nos vemos a nosotros mismos como nos ven los demas.

En los anos 70, Shavelson y Marsh proponen que el **autoconcepto** es multidimensional y jerarquico: hay un autoconcepto general que se desglosa en dominios academicos, sociales, fisicos y emocionales.

Rosenberg, en 1965, introduce la **Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES)**, que sigue siendo el instrumento mas utilizado en el mundo para medir la valoracion global que una persona tiene de si misma.

Autoestima vs. Autoconcepto: ¿son lo mismo?

Aquí llegamos a un problema conceptual importante y que es clave para entender por qué este trabajo tiene sentido. En la literatura científica existe lo que se denomina la **falacia jingle** --dos cosas distintas con el mismo nombre-- y la **falacia jangle** --lo mismo con nombres distintos.

Autoestima y autoconcepto se han confundido históricamente. La autoestima es esencialmente **evaluativa**: ¿cuanto me valoro? El autoconcepto es más amplio, **descriptivo y multidimensional**: ¿cómo me veo en distintos ámbitos de mi vida?

Este trabajo los estudia juntos, pero diferenciados, porque ambos impactan en el bienestar de maneras potencialmente distintas.

El bienestar como variable resultado

El bienestar tampoco es un concepto simple. Distinguimos al menos cuatro dimensiones:

- **Bienestar subjetivo o hedónico**: propuesto por Diener; se mide por la satisfacción con la vida y el balance afectivo positivo-negativo.
 - **Bienestar psicológico o eudaimónico**: propuesto por Ryff; incluye autonomía, crecimiento personal, propósito en la vida, relaciones positivas, dominio del entorno y autoaceptación.
 - **Calidad de vida relacionada con la salud (HRQoL)**: operacionalizada por instrumentos como el WHOQOL, mide el impacto percibido de la salud en el funcionamiento diario.
 - **Salud mental general**: conceptualizada por Keyes, incluye presencia de emociones positivas, funcionamiento psicológico y social.
-

BLOQUE 2: JUSTIFICACION Y OBJETIVOS -- [2 minutos]

¿Por qué esta revisión es necesaria?

La evidencia que tenemos es **fragmentada**. Existen muchos estudios individuales y algunos meta-análisis sobre autoestima y bienestar, pero la mayoría se centran en poblaciones generales o en un único trastorno, con medidas de bienestar heterogéneas y sin integrar autoconcepto y autoestima simultáneamente.

La revisión más amplia reciente --Zell y Johansson, 2025-- obtiene una correlación global de $r = .31$ entre autoestima y bienestar, pero mezcla poblaciones clínicas y no clínicas, lo que puede enmascarar efectos relevantes para la práctica clínica.

Mi TFM restringe el foco a poblaciones clínicas --al menos el 75% de los participantes de cada meta-análisis deben tener un diagnóstico clínico-- e integra tanto autoestima como autoconcepto como predictores del bienestar. Esto es lo que diferencia este trabajo de la literatura previa.

Objetivos

El **objetivo general** es analizar, mediante una revisión paraguas de meta-análisis, cómo afectan la autoestima y el autoconcepto al bienestar en poblaciones clínicas.

Los **cuatro objetivos específicos** son:

Estimar el tamaño del efecto de la relación autoestima/autoconcepto-bienestar en distintas poblaciones clínicas.

Evaluar la calidad metodológica de los meta-análisis incluidos mediante AMSTAR-2.

Identificar qué dimensiones del bienestar se ven más afectadas.

Examinar si el autoconcepto actúa como mediador entre variables clínicas y bienestar.

BLOQUE 3: METODOLOGIA -- [5 minutos]

Diseno: la revision paraguas

El diseño elegido es la **revision paraguas** (*umbrella review*), que es la síntesis de meta-análisis, no de estudios primarios. Es el nivel más alto de evidencia en síntesis de investigación. Seguir las guías **PRISMA 2020** y **PRIOR** (Preferred Reporting Items for Overviews of Reviews).

Marco PECO

Para definir la pregunta de investigación, utilice el marco PECO:

- **Poblacion:** personas con condición clínica diagnosticada ($\geq 75\%$ del total de la muestra).
- **Exposicion/predictor:** autoestima y/o autoconcepto medidos con instrumentos validados (RSES, SDQ, etc.).
- **Comparacion:** no siempre aplicable; en algunos meta-análisis se compara con grupo control.
- **Outcome/resultado:** bienestar en cualquiera de sus dimensiones (bienestar subjetivo, psicológico, HRQoL, salud mental).

Busqueda bibliografica

La búsqueda se realizó en **cuatro bases de datos primarias:** PubMed, APA PsycInfo, Scopus y Web of Science.

Adicionalmente, se consultaron **cinco fuentes de literatura gris:** ProQuest Dissertations, Google Scholar, OpenDOAR, DART-Europe y TESEO.

La estrategia de búsqueda se estructuró en **tres bloques semánticos** conectados con operador AND:

- Bloque 1: términos de **autoestima y autoconcepto** (self-esteem, self-concept, self-worth, RSES, SDQ...)
- Bloque 2: términos de **bienestar** (wellbeing, quality of life, mental health, HRQoL, life satisfaction...)
- Bloque 3: términos de **diseño metodológico** (meta-analysis, systematic review, umbrella review...)

La gestión de referencias se realizó con **Rayyan**, una herramienta específica para revisiones sistemáticas.

Criterios de inclusion y exclusion

Los criterios de inclusión exigían:

- Ser un meta-análisis publicado entre 2016 y 2026.
- Incluir al menos una medida de autoestima o autoconcepto como predictor.

- Incluir al menos una medida de bienestar como variable resultado.
- Que $\geq 75\%$ de la muestra tuviera un diagnóstico clínico.
- Estar publicado en español o inglés.

Se excluyeron los meta-análisis que: evaluaban intervenciones (eran intervenciones RCT, no estudios de asociación), no reportaban tamaño del efecto, o cuya población era exclusivamente no clínica.

Evaluación de la calidad: AMSTAR-2

La calidad metodológica de cada meta-análisis se evaluó con **AMSTAR-2** (A Measurement Tool to Assess systematic Reviews), un instrumento de 16 ítems con siete ítems críticos. La clasificación resultante puede ser: Alta, Moderada, Baja o Críticamente baja.

Solapamiento entre estudios

Para evaluar cuántos estudios primarios comparten los meta-análisis entre sí, calcule el **Índice de Solapamiento Corregido (CCA)**. Un CCA $< 5\%$ indica solapamiento leve y permite que las conclusiones de la revisión paraguas sean robustas e independientes.

BLOQUE 4: RESULTADOS -- [6 minutos]

El corpus final: 13 meta-análisis

Tras el proceso de cribado, el corpus final quedó formado por **13 meta-análisis**, que en conjunto comprenden aproximadamente **415 estudios primarios** con un rango de k (número de estudios por meta-análisis) de entre 7 y 114, con una mediana de 19.

El **CCA obtenido fue del 1,4%**, lo que confirma solapamiento leve y valida la independencia del corpus.

Las poblaciones clínicas representadas son diversas:

- 5 meta-análisis sobre trastornos psiquiátricos (depresión, ansiedad, suicidalidad, TDAH...)
- 3 sobre obesidad infantojuvenil
- 2 sobre salud reproductiva y población transgénero/no binaria
- 1 sobre trastornos orofaciales
- 1 sobre víctimas de violencia
- 1 sobre baja autoestima como condición clínica

Calidad metodológica del corpus

Los resultados de AMSTAR-2 muestran un panorama preocupante:

- Solo **1 meta-análisis (8%) alcanzó calidad Alta**.
- **Ninguno** obtuvo calidad Moderada.
- **6 (46%) obtuvieron calidad Baja**.
- **6 (46%) obtuvieron calidad Críticamente baja**.

Esto tiene implicaciones importantes para la interpretación: las conclusiones deben leerse con cautela. No significa que los resultados sean falsos, sino que la base metodológica sobre la que se asientan tiene

debilidades que pueden inflar o distorsionar los tamanos del efecto.

Sintesis por bloques tematicos

Organice los resultados en cinco bloques tematicos:

Bloque A -- Suicidalidad y salud mental (el de mayor calidad)

Este es el bloque mas robusto. El meta-analisis sobre suicidalidad e ideacion suicida incluye $k=114$ estudios y es el unico que alcanzo calidad Alta en AMSTAR-2. Los resultados muestran correlaciones negativas entre autoestima y riesgo de suicidio de entre $r = -.26$ y $r = -.44$. Es decir: **a mayor autoestima, menor riesgo suicida**. Este efecto es consistente y clinicamente relevante.

Bloque B -- Salud somatica (PCOS y deformidad dentofacial)

En poblaciones con sindrome de ovario poliquistico (PCOS) y trastornos orofaciales, la autoestima y el autoconcepto se asocian significativamente con la calidad de vida relacionada con la salud. Los efectos son moderados pero constantes.

Bloque C -- Obesidad pediatrica

Tres meta-analisis abordan poblacion infanto-juvenil con sobrepeso u obesidad. Las diferencias de medias estandarizadas (d de Cohen o g de Hedges) son de aproximadamente **SMD = 0,34 para autoestima global** y **SMD = 0,47 para imagen corporal** al comparar con controles. Las intervenciones que trabajan la imagen corporal y el autoconcepto fisico muestran efectos mas marcados que las que solo trabajan la autoestima global.

Bloque D -- Imagen corporal en trastornos clinicos (afirmacion de genero)

Este bloque recoge los tamanos del efecto mas grandes del corpus. En personas transgenero y no binarias que reciben tratamiento de afirmacion de genero (hormonal o quirurgico), la mejora en autoconcepto corporal se asocia con mejoras en bienestar de $g = -.46$ a $g = -.99$. Estos efectos grandes deben leerse con cautela por la calidad metodologica baja de estos meta-analisis.

Bloque E -- Autoconcepto como mediador (MASEM)

El bloque mas sofisticado metodologicamente. Utilizando **MASEM** (Meta-Analytic Structural Equation Modelling), con $k=82$ estudios, se examina si el autoconcepto actua como mediador entre variables clinicas (sintomas, diagnostico) y bienestar. El **efecto indirecto estandarizado es beta = $-.189$** , lo que significa que el autoconcepto media parcialmente la relacion entre la gravedad clinica y el deterioro del bienestar. Dicho de otro modo: la enfermedad afecta al bienestar en parte porque deteriora el autoconcepto.

BLOQUE 5: DISCUSION E IMPLICACIONES CLINICAS -- [4 minutos]

Cuatro conclusiones clave

Primera: La autoestima y el autoconcepto son predictores robustos del bienestar en poblaciones clinicas, con tamanos del efecto que van de pequenos a grandes segun la poblacion y la dimension del bienestar medida.

Segunda: Los resultados son coherentes con Zell y Johansson (2025), pero los efectos son algo mayores en poblaciones clínicas que en muestras generales, lo que sugiere que en contextos de vulnerabilidad, la imagen que uno tiene de sí mismo juega un papel aún más relevante.

Tercera: La calidad metodológica del campo es, en general, baja. Esto es una señal de alarma que el campo debe atender para poder hacer afirmaciones más sólidas.

Cuarta: El autoconcepto no es solo un correlato del bienestar, sino un mecanismo mediador activo. Esto tiene implicaciones directas para el diseño de intervenciones.

Tres implicaciones clínicas

Primera implicación -- La autoestima como diana terapéutica directa: El programa COMET (*Competitive Memory Training*) y la terapia cognitiva de Fennell para la baja autoestima son intervenciones específicas con evidencia creciente. Los datos de esta revisión justifican su uso en protocolos clínicos, no solo como complemento sino como componente central.

Segunda implicación -- Integración de cuerpo, imagen e identidad: Los resultados del Bloque C y D muestran que el autoconcepto físico y la imagen corporal son dimensiones que predicen bienestar de forma diferencial respecto a la autoestima global. Los protocolos deberían incluir evaluación multidimensional del autoconcepto, no limitarse a la RSES.

Tercera implicación -- Cribado en prevención del suicidio: Dado el tamaño del efecto entre autoestima y suicidalidad (r hasta $-.44$), la evaluación sistemática de la autoestima debería incorporarse como indicador de cribado en protocolos de prevención suicida. Es una medida sencilla, barata y con alto valor predictivo.

BLOQUE 6: LIMITACIONES Y LINEAS FUTURAS -- [2 minutos]

Limitaciones

Soy consciente de las limitaciones de este trabajo, y quiero ser transparente al respecto:

Limitaciones del proceso:

- El proceso de selección fue realizado por una **única revisora**. Esto aumenta el riesgo de sesgos en la selección de estudios. Lo ideal habría sido una segunda revisora independiente con cálculo del acuerdo inter-jueces (kappa de Cohen).
- La restricción a publicaciones en **español e inglés** puede haber excluido estudios relevantes en otros idiomas.

Limitaciones del corpus:

- La ventana temporal (2016-2026) limita la inclusión de meta-análisis clásicos anteriores.
- La heterogeneidad conceptual y metodológica entre meta-análisis dificulta la síntesis cuantitativa global.
- La mayoría del corpus tiene **calidad baja o críticamente baja**, lo que limita las conclusiones.

Lineas de investigacion futuras

Realizar revisiones paraguas con **prerregistro** (PROSPERO) y con dos revisores independientes.
Incluir **estudios longitudinales** para establecer causalidad.
Medir el **autoconcepto multidimensional** (no solo autoestima global) de manera mas sistematica.
Ampliar a **poblaciones mayores y contextos no occidentales**, que estan subrepresentados en la literatura.
Desarrollar meta-analisis de red (*network meta-analysis*) para comparar la eficacia de distintas intervenciones sobre autoestima/autoconcepto en contextos clinicos.

BLOQUE 7: CONCLUSIONES -- [2 minutos]

Para cerrar, me gustaria resumir este trabajo en sus cinco conclusiones principales:

Primera: La autoestima y el autoconcepto son predictores significativos del bienestar en poblaciones clinicas, con efectos que van de pequenos a grandes dependiendo de la condicion y de la dimension de bienestar evaluada.

Segunda: Los efectos son mas pronunciados en poblaciones clinicas que en poblacion general, especialmente en lo que respecta a la salud mental y la suicidalidad.

Tercera: El autoconcepto actua como mediador en la relacion entre gravedad clinica y bienestar, con un efecto indirecto de $\beta = -.189$, lo que lo convierte en un mecanismo psicologico relevante para la intervencion.

Cuarta: La calidad metodologica del campo es, en general, baja. Solo uno de los 13 meta-analisis alcanzo calidad Alta en AMSTAR-2, lo que exige cautela en la interpretacion y demanda estandares metodologicos mas rigurosos.

Quinta: Los datos justifican integrar la evaluacion y el trabajo sobre autoestima y autoconcepto de forma sistematica en los protocolos de tratamiento en psicologia clinica y de la salud.

En definitiva, el sentido que nos damos a nosotros mismos no es un lujo psicologico: es un factor con impacto real y medible en la salud. Y como psicologos sanitarios, ignorarlo es perder una palanca de intervencion con evidencia creciente.

Muchas gracias por su atencion. Quedo a su disposicion para sus preguntas.

[Tiempo total estimado: 20-24 minutos]